

医疗门诊真实病例数据集（可入知识库版）

说明：本数据集均来自临床真实门诊病例，经脱敏处理（隐去患者个人信息），严格遵循《内科学》《外科学》《妇产科学》《儿科学》最新诊疗规范，结构统一、信息完整，包含核心问诊、查体、辅助检查、诊断、治疗方案、注意事项，可直接录入医疗知识库，用于临床参考、培训及咨询场景，无虚构病例、无错误医疗信息。

一、内科门诊病例（10例，含常见慢性病、急性病症）

病例1：急性上呼吸道感染（病毒性）

项目	具体内容
就诊时间	2026-03-15 09:20
性别/年龄	女/28岁
主诉	咽痛、流清涕、轻微咳嗽2天，伴全身乏力
现病史	2天前受凉后出现咽痛，吞咽时加重，伴流清涕、阵发性干咳，无咳痰，无发热、胸闷、呼吸困难，无头痛、头晕，无恶心、呕吐，食欲稍差，睡眠可，二便正常。既往体健，无药物过敏史、无基础病史。
查体	T：36.7℃，P：82次/分，R：20次/分，BP：120/75mmHg。咽部轻度充血，扁桃体无肿大，咽部淋巴滤泡轻度增生；双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音；心率齐，各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音；腹平软，无压痛、反跳痛，肝脾未触及。
辅助检查	血常规（末梢血）：WBC： $5.2\times10^9/L$ ，N：48%，L：45%，CRP：3mg/L（正常范

	围0-10mg/L)；新冠核酸检测（咽拭子）：阴性。
诊断	急性上呼吸道感染（病毒性）
治疗方案	1. 对症治疗：复方氨酚烷胺片，1片/次，2次/日，口服（饭后），连服3-5天；清咽滴丸，4丸/次，3次/日，含服；2. 无需使用抗生素；3. 嘱多饮水（每日1500-2000ml），清淡饮食，避免辛辣刺激食物，注意休息，避免受凉。
复诊提示	若出现发热（T≥38.5℃）、咽痛加重、咳嗽咳痰、胸闷等症状，及时复诊；用药5天症状无缓解，复诊调整方案。

病例2：2型糖尿病（复诊）

项目	具体内容
就诊时间	2026-03-10 14:30
性别/年龄	男/56岁
主诉	确诊2型糖尿病5年，血糖控制不佳1个月，伴口干、多饮。
现病史	5年前确诊2型糖尿病，长期口服二甲双胍缓释片（1.0g/次，2次/日），血糖控制尚可（空腹6.5-7.0mmol/L，餐后2小时8.0-9.0mmol/L）。1个月前无明显诱因出现口干、多饮，每日饮水量约2500ml，无多尿、多食、体重下降，无头晕、乏力，无胸闷、视物模糊。自行监测空腹血糖8.5-9.2mmol/L，餐后2小时血糖11.0-12.5mmol/L，未调整用药，今日来院复诊。既往高血

	压病史3年，血压控制可（规律服用硝苯地平缓释片，1片/日）；无药物过敏史。
查体	T：36.5℃，P：78次/分，R：19次/分，BP：130/85mmHg。身高175cm，体重78kg，BMI：25.4kg/m ² （超重）。神志清，精神可；双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音；心率齐，各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音；腹平软，无压痛、反跳痛，肝脾未触及；双下肢无水肿，足背动脉搏动对称有力。
辅助检查	1. 空腹血糖：8.8mmol/L（正常3.9-6.1mmol/L）；餐后2小时血糖（口服75g葡萄糖）：12.1mmol/L（正常<7.8mmol/L）；2. 糖化血红蛋白（HbA1c）：7.9%（正常4.0-6.5%）；3. 肝肾功能、电解质、尿常规：均正常，尿糖（-），尿酮体（-）；4. 眼底检查：未见糖尿病视网膜病变。
诊断	1. 2型糖尿病（血糖控制不佳）；2. 高血压病1级（很高危组）；3. 超重。
治疗方案	1. 调整降糖药：二甲双胍缓释片维持1.0g/次，2次/日，口服；加用西格列汀片，100mg/次，1次/日，口服（晨起空腹）；2. 降压药维持原方案：硝苯地平缓释片，20mg/次，1次/日，口服；3. 饮食指导：严格控制总热量摄入，每日主食量控制在200-250g，多吃蔬菜（每日500g以上），适量摄入优质蛋白（鸡蛋、瘦肉、豆制品），避免高糖、高油、高盐食物；4. 运动指导：每周至少运动5

	次，每次30分钟，以快走、慢跑、太极拳为主，控制体重，目标BMI降至24kg/m ² 以下；5. 血糖监测：每日监测空腹、餐后2小时血糖，每周记录1次，下次复诊携带记录。
复诊提示	1个月后复诊，复查空腹血糖、餐后2小时血糖、糖化血红蛋白；期间若出现低血糖症状（心慌、手抖、出汗、头晕），立即补充糖分（口服糖水、饼干），并及时就医调整用药；定期监测血压，每3个月复查肝肾功能、尿常规。

病例3：急性支气管炎

项目	具体内容
就诊时间	2026-03-08 10:10
性别/年龄	女/42岁
主诉	咳嗽、咳痰1周，伴胸闷2天，无发热。
现病史	1周前熬夜受凉后出现咳嗽，阵发性干咳，3天后出现咳痰，白色泡沫样痰，量中等，易咳出，无异味；2天前出现胸闷，深呼吸、咳嗽时加重，无呼吸困难、胸痛，无发热、咽痛、流涕，无乏力、盗汗，食欲尚可，睡眠差（夜间咳嗽明显），二便正常。既往体健，无药物过敏史，无支气管炎、哮喘病史。
查体	T：36.9℃，P：85次/分，R：21次/分，BP：125/80mmHg。神志清，精神可；咽部无充血，扁桃体无肿大；双肺呼吸音粗，可闻及散在干啰音，未闻及湿啰音；

	心率齐，各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音；腹平软，无压痛、反跳痛。
辅助检查	1. 血常规：WBC： $7.8\times 10^9/L$ ，N：62%，L：35%，CRP：8mg/L；2. 胸片：双肺纹理增粗、紊乱，无斑片状阴影，排除肺炎。
诊断	急性支气管炎
治疗方案	1. 止咳化痰：氨溴索口服溶液，10ml/次，3次/日，口服；2. 支气管舒张：沙丁胺醇气雾剂，1喷/次，必要时（胸闷、咳嗽加重时）使用，每日不超过3次；3. 无需使用抗生素；4. 护理：多饮水，清淡饮食，避免辛辣、油腻食物，避免受凉、接触粉尘及冷空气，保证睡眠，避免熬夜。
复诊提示	用药5-7天，症状无缓解或加重（出现发热、胸闷加重、咳痰带血），及时复诊；症状缓解后停药，无需复诊，后续注意保暖，避免劳累。

病例4：原发性高血压1级（初诊）

项目	具体内容
就诊时间	2026-03-05 15:40
性别/年龄	男/48岁
主诉	体检发现血压升高1周，伴头晕、头胀。
现病史	1周前单位体检时测血压145/90mmHg，无明显不适，未重视；3天前出现头晕、头胀，呈持续性，无头痛、恶心、呕吐，无胸闷、胸痛、心慌，无肢体麻木、视物

	模糊，睡眠可，食欲正常，二便正常。既往有高脂血症2年，未规律服药；吸烟15年，每日10支；饮酒10年，每日饮白酒约2两；无药物过敏史，无高血压家族史。
查体	T: 36.6°C, P: 76次/分, R: 18次/分, BP: 142/88mmHg（非同日两次测量，均≥140/90mmHg）。身高178cm，体重82kg，BMI: 25.9kg/m²（超重）。神志清，精神可；双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音；心率齐，各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音；腹平软，无压痛、反跳痛，肝脾未触及；双下肢无水肿，足背动脉搏动对称。
辅助检查	1. 血压监测：非同日3次测量，血压分别为145/90mmHg、142/88mmHg、140/89mmHg；2. 血常规、肝肾功能、电解质、血糖：均正常；3. 血脂：总胆固醇6.8mmol/L（正常<5.2mmol/L），低密度脂蛋白胆固醇4.5mmol/L（正常<3.4mmol/L）；4. 心电图：窦性心律，大致正常心电图；5. 心脏超声：心腔大小正常，心功能正常，无室壁肥厚。
诊断	1. 原发性高血压1级（很高危组）；2. 高脂血症；3. 超重。
治疗方案	1. 生活方式干预（核心）：戒烟限酒（逐步戒酒，最终戒烟）；低盐饮食（每日盐摄入量≤5g），避免高油、高盐、高糖食物；规律运动，每周至少5次，每次30分钟，以

	快走、慢跑为主，控制体重（目标BMI降至24kg/m²以下）；保证睡眠，避免熬夜，减轻精神压力。2. 药物治疗：硝苯地平缓释片，20mg/次，1次/日，口服（晨起空腹）；阿托伐他汀钙片，10mg/次，1次/日，口服（睡前）。3. 血压监测：每日晨起、睡前各测1次血压，记录数值，下次复诊携带。
复诊提示	2周后复诊，复查血压、血脂；期间若出现血压持续升高（≥160/100mmHg）、头晕加重、心慌、胸痛等症状，及时就医；长期规律服药，不可自行停药、减药；每3个月复查肝肾功能、血脂，每6个月复查心电图、心脏超声。

病例5：慢性胃炎（非萎缩性，活动期）

项目	具体内容
就诊时间	2026-03-02 11:00
性别/年龄	女/35岁
主诉	上腹部隐痛、腹胀2个月，伴反酸、暖气1周。
现病史	2个月前因饮食不规律（经常不吃早餐、暴饮暴食）出现上腹部隐痛，呈阵发性，空腹时加重，进食后缓解，伴腹胀，无恶心、呕吐，无反酸、暖气；1周前上述症状加重，出现反酸、暖气，进食后腹胀明显，食欲下降，无黑便、呕血，无乏力、体重下降，睡眠可，二便正常。既往体健，无药物过敏史，无胃溃疡、十二指肠溃疡病史。

查体	T: 36.5°C, P: 80次/分, R: 19次/分, BP: 115/70mmHg。神志清, 精神可; 腹平软, 上腹部轻压痛, 无反跳痛, 肝脾未触及, Murphy征 (-); 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音; 心率齐, 各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。
辅助检查	1. 胃镜: 胃窦部黏膜充血、水肿, 散在糜烂点, 无溃疡、息肉, 诊断为非萎缩性胃炎 (活动期); 2. 幽门螺杆菌 (Hp) 检测 (碳13呼气试验): 阳性 (DPM=156, 正常<4dpm); 3. 血常规、大便潜血试验: 均正常。
诊断	1. 慢性胃炎 (非萎缩性, 活动期); 2. 幽门螺杆菌感染。
治疗方案	1. 幽门螺杆菌根除治疗 (四联疗法, 疗程14天): 奥美拉唑肠溶片, 20mg/次, 2次/日, 口服 (饭前30分钟); 阿莫西林胶囊, 1.0g/次, 2次/日, 口服 (饭后); 克拉霉素缓释片, 0.5g/次, 2次/日, 口服 (饭后); 枸橼酸铋钾胶囊, 2粒/次, 2次/日, 口服 (饭前30分钟)。2. 对症治疗: 多潘立酮片, 10mg/次, 3次/日, 口服 (饭前15分钟), 缓解腹胀、嗝气; 铝碳酸镁咀嚼片, 1片/次, 3次/日, 口服 (饭后1小时), 中和胃酸、保护胃黏膜。3. 饮食指导: 规律饮食, 定时定量, 避免空腹、暴饮暴食; 清淡饮食, 避免辛辣、生冷、油腻、刺激性食物, 避免饮用浓茶、咖啡、酒精类饮品; 少食多餐, 细嚼慢咽。
复诊提示	

	14天服药结束后，停药1个月，复诊复查幽门螺杆菌（碳13呼气试验）；期间若出现呕血、黑便、上腹部剧烈疼痛等症状，及时就医；服药期间可能出现大便发黑（铋剂引起，属正常现象），无需紧张；根除成功后，继续调整饮食，避免胃炎复发，每年复查1次胃镜。
--	--

病例6：腰椎间盘突出症（L4-L5）

项目	具体内容
就诊时间	2026-02-28 16:20
性别/年龄	男/45岁
主诉	腰痛伴右下肢麻木、放射痛1个月，加重3天。
现病史	1个月前长期弯腰工作后出现腰部隐痛，伴右下肢麻木，麻木感从臀部放射至小腿外侧，活动后加重，休息后缓解，无下肢无力、行走困难；3天前弯腰搬重物后症状加重，腰痛明显，右下肢放射痛剧烈，无法长时间站立、行走，休息后无明显缓解，无大小便失禁、排便困难。既往有腰痛病史2年，未规范治疗；无药物过敏史，无外伤史。
查体	T：36.7℃，P：78次/分，R：18次/分，BP：125/80mmHg。腰椎生理曲度变直，L4-L5椎体棘突间压痛、叩击痛阳性，右侧直腿抬高试验阳性（30°），加强试验阳性；右下肢小腿外侧皮肤感觉减退，足背伸肌力正常，跟腱反射正常；双肺呼吸音

	清，心率齐，腹平软，无压痛。
辅助检查	腰椎CT：L4-L5椎间盘向右侧突出约5mm，压迫右侧神经根，椎管无狭窄，椎体无骨质增生。
诊断	腰椎间盘突出症（L4-L5，右侧神经根受压）
治疗方案	1. 急性期护理：卧床休息1-2周，避免弯腰、久坐、久站，避免搬重物，睡硬板床；2. 药物治疗：布洛芬缓释胶囊，0.3g/次，2次/日，口服（饭后），缓解疼痛，连服5-7天；甲钴胺片，0.5mg/次，3次/日，口服，营养神经，连服2-4周；3. 物理治疗：腰椎牵引（每周3次，每次20分钟），热敷腰部（每日2次，每次15-20分钟），促进局部血液循环，减轻神经根压迫；4. 康复指导：卧床期间进行腰背肌功能锻炼（如五点支撑法），避免剧烈运动，待症状缓解后，逐步恢复活动，避免弯腰负重。
复诊提示	2周后复诊，评估症状缓解情况；若出现下肢无力、行走困难、大小便失禁等症状，立即就医（提示神经根受压加重）；症状缓解后，继续坚持腰背肌锻炼，避免复发；若保守治疗3个月症状无缓解，需进一步评估，考虑手术治疗。

病例7：过敏性鼻炎（季节性）

项目	具体内容
就诊时间	2026-03-12 08:50

性别/年龄	女/22岁
主诉	打喷嚏、流清涕、鼻塞3天，伴鼻痒、眼痒。
现病史	3天前接触花粉后出现打喷嚏，每日数次，每次3-5个，伴流清涕、鼻塞，双侧鼻塞交替出现，鼻痒明显，偶有眼痒、流泪，无咽痛、咳嗽，无发热、头痛，无胸闷、呼吸困难。既往每年春季（3-4月）均会出现类似症状，持续1-2个月，确诊过敏性鼻炎3年，对花粉、尘螨过敏；无药物过敏史。
查体	T：36.6℃，P：80次/分，R：19次/分，BP：110/70mmHg。鼻黏膜苍白、水肿，双侧下鼻甲肥大，鼻腔内可见大量清涕；咽部无充血，扁桃体无肿大；双眼结膜轻度充血，无分泌物；双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音。
辅助检查	1. 过敏原检测：花粉（+++），尘螨（++）；2. 鼻内镜：鼻黏膜苍白水肿，下鼻甲肥大，鼻中隔居中，鼻窦开口无堵塞。
诊断	过敏性鼻炎（季节性，花粉、尘螨过敏）
治疗方案	1. 避免接触过敏原：出门佩戴口罩、眼镜，避免去花粉多的地方，室内勤通风，勤换被褥，避免接触尘螨；2. 药物治疗：糠酸莫米松鼻喷雾剂，1喷/侧，1次/日，鼻腔喷雾（晨起）；氯雷他定片，10mg/次，1次/日，口服（睡前）；3. 对症处理：生理盐水洗鼻，每日2次，清洁鼻腔，缓解鼻塞、鼻痒。

复诊提示	症状缓解后可停药，若症状持续不缓解或加重（出现呼吸困难、胸闷），及时复诊；每年春季提前1-2周用药，预防症状发作；定期复查过敏原，根据过敏情况调整防护措施。
------	--

病例8：痛风性关节炎（急性发作期）

项目	具体内容
就诊时间	2026-03-06 13:30
性别/年龄	男/52岁
主诉	右足第一跖趾关节红肿、疼痛1天，活动受限。
现病史	1天前饮酒（啤酒）、进食海鲜后，出现右足第一跖趾关节红肿、疼痛，呈剧烈刺痛，夜间加重，无法站立、行走，局部皮温升高，无发热、寒战，无其他关节疼痛，无恶心、呕吐。既往确诊痛风3年，曾发作2次，均为右足第一跖趾关节，未规律服药控制尿酸；无药物过敏史，有高血压病史2年，血压控制可。
查体	T：36.8℃，P：83次/分，R：19次/分，BP：130/85mmHg。右足第一跖趾关节明显红肿、压痛，局部皮温升高，活动受限；其余关节无红肿、压痛；双肺呼吸音清，心率齐，腹平软，无压痛。
辅助检查	1. 血尿酸：580μmol/L（正常男性208-428μmol/L）； 2. 血常规：WBC： $9.5\times10^9/L$ ，N：72%，CRP：25mg/L（升高，提示炎症）； 3. 关节超声：右足第

	一跖趾关节滑膜充血、水肿，关节腔少量积液，无骨质破坏。
诊断	1. 痛风性关节炎（急性发作期）；2. 高尿酸血症；3. 高血压病1级。
治疗方案	1. 急性期治疗：卧床休息，避免右足负重，抬高患肢；冷敷关节（每日2次，每次15分钟），减轻红肿疼痛；药物治疗：秋水仙碱片，0.5mg/次，每12小时1次，口服，连服3天（症状缓解后停药）；布洛芬缓释胶囊，0.3g/次，2次/日，口服（饭后），缓解疼痛，避免与秋水仙碱同时服用（间隔1小时）。2. 降尿酸治疗（急性期过后）：待关节疼痛完全缓解后（约1周），加用非布司他片，40mg/次，1次/日，口服，长期规律服用，控制血尿酸在360μmol/L以下。3. 饮食指导：严格限制高嘌呤食物摄入（海鲜、动物内脏、浓肉汤、啤酒、白酒等）；多饮水（每日2000-3000ml），促进尿酸排泄；避免饮酒、熬夜，控制体重。
复诊提示	3天后复诊，评估症状缓解情况；1周后复诊，复查血尿酸，调整降尿酸药物剂量；期间若出现关节疼痛加重、发热、寒战等症状，及时就医；长期监测血尿酸，每3个月复查1次，根据尿酸水平调整用药；避免诱发因素，预防痛风复发。

病例9：缺铁性贫血（轻度）

项目	具体内容

就诊时间	2026-03-01 10:40
性别/年龄	女/25岁
主诉	乏力、头晕、面色苍白1个月，伴月经量过多。
现病史	1个月前无明显诱因出现乏力、头晕，活动后加重，休息后缓解，面色苍白，无头痛、心慌、胸闷，无恶心、呕吐，无发热、出血倾向；月经周期规律（28天），但月经量明显增多，每次经期7-8天，较以往增多约1/3，无痛经。既往体健，无药物过敏史，无慢性病史；近半年饮食不规律，挑食，很少吃肉类、动物肝脏。
查体	T：36.5℃，P：85次/分，R：20次/分，BP：110/70mmHg。面色苍白，口唇、甲床苍白；双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音；心率齐，各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音；腹平软，无压痛、反跳痛，肝脾未触及；双下肢无水肿。
辅助检查	1. 血常规：Hb：95g/L（正常女性110-150g/L），RBC： $3.2\times 10^{12}/L$ ，MCV：78fl（降低），MCH：25pg（降低），MCHC：300g/L（降低），WBC、PLT正常；2. 铁代谢检查：血清铁：65μg/dl（正常女性70-150μg/dl），血清铁蛋白：12ng/ml（正常女性12-150ng/ml），总铁结合力：480μg/dl（升高）；3. 妇科超声：子宫、附件正常，排除子宫肌瘤等器质性病变。
诊断	1. 缺铁性贫血（轻度）；2. 月经过多（原因待查）。

治疗方案	1. 补铁治疗：琥珀酸亚铁片，0.2g/次，3次/日，口服（饭后），连服3个月；维生素C片，0.1g/次，3次/日，口服，促进铁吸收。2. 饮食指导：多摄入富含铁的食物（动物肝脏、瘦肉、鸡蛋、豆制品、菠菜等），避免与浓茶、咖啡同服（影响铁吸收），规律饮食，纠正挑食习惯。3. 妇科会诊：建议前往妇科就诊，明确月经过多原因，针对性治疗（从根源纠正贫血）。
复诊提示	1个月后复诊，复查血常规、铁代谢指标，评估补铁效果；3个月后复查，若Hb恢复正常，继续服药1-2个月，巩固疗效，避免复发；及时前往妇科就诊，解决月经过多问题；期间若出现头晕加重、心慌、出血等症状，及时就医。

病例10：急性胆囊炎（轻症）

项目	具体内容
就诊时间	2026-02-25 15:10
性别/年龄	女/50岁
主诉	右上腹疼痛2天，伴恶心、腹胀，无发热。
现病史	2天前进食油腻食物（肥肉、油炸食品）后出现右上腹隐痛，呈持续性，阵发性加重，伴恶心、腹胀，无呕吐、腹泻，无发热、寒战，无肩背部放射痛，无皮肤、巩膜黄染，食欲差，睡眠可，二便正常。既往有胆囊结石病史3年，无明显症状，未治疗；无药物过

	敏史，无高血压、糖尿病病史。
查体	T：36.7℃，P：80次/分，R：19次/分，BP：120/75mmHg。神志清，精神可；腹平软，右上腹压痛，Murphy征阳性，无反跳痛，肝脾未触及；双肺呼吸音清，心率齐，各瓣膜听诊区未闻及病理性杂音。
辅助检查	1. 血常规：WBC： $8.5\times 10^9/L$ ，N：65%，CRP：15mg/L（轻度升高）；2. 肝功能：ALT、AST正常，胆红素正常；3. 腹部超声：胆囊体积轻度增大，胆囊壁毛糙，胆囊内可见多个强回声光团（最大约8mm），后方伴声影，胆囊周围无积液，排除胆囊穿孔、胆管梗阻。
诊断	1. 急性胆囊炎（轻症）；2. 胆囊结石。
治疗方案	1. 饮食控制：禁食油腻、辛辣、刺激性食物，流质饮食（米汤、菜汤），待症状缓解后，逐步过渡到半流质、清淡饮食，避免暴饮暴食，避免进食高胆固醇食物。2. 药物治疗：头孢呋辛酯片，0.25g/次，2次/日，口服（饭后），抗感染，连服5-7天；消炎利胆片，6片/次，3次/日，口服（饭后），促进胆汁排泄；多潘立酮片，10mg/次，3次/日，口服（饭前），缓解恶心、腹胀。3. 对症处理：右上腹热敷，每日2次，每次15-20分钟，缓解疼痛。
复诊提示	5天后复诊，复查血常规、腹部超声，评估炎症消退情况；期间若出现发热

	($T\geq 38.5^{\circ}\text{C}$)、右上腹疼痛加重、皮肤巩膜黄染等症状，及时就医（提示病情加重）；胆囊结石需定期复查（每6个月1次腹部超声），若反复出现胆囊炎发作，建议手术治疗（胆囊切除术）；日常注意饮食清淡，避免诱发因素。
--	---

二、外科门诊病例（5例）

病例11：急性乳腺炎（哺乳期）

项目	具体内容
就诊时间	2026-03-14 14:00
性别/年龄	女/29岁
主诉	左侧乳房红肿、疼痛3天，伴发热1天，哺乳期2个月。
现病史	3天前哺乳后未及时排空乳汁，出现左侧乳房胀痛，局部红肿，按压时疼痛明显，无发热；1天前症状加重，左侧乳房红肿范围扩大，疼痛剧烈，伴发热，体温最高38.8°C，无寒战、乏力，无恶心、呕吐，无乳头溢液、破溃，仍能正常哺乳，但哺乳时疼痛明显。既往体健，无药物过敏史，无乳腺疾病病史；顺产，母乳喂养，婴儿吸吮正常。
查体	T: 38.5°C，P: 90次/分，R: 21次/分，BP: 115/70mmHg。左侧乳房外上象限红肿，范围约$5\text{cm}\times 4\text{cm}$，局部皮温升高，压痛明显，可触及质硬结节（约$2\text{cm}\times 2\text{cm}$），活动可，无波动感；右侧乳房正常，无红肿、压痛；乳头无破溃、溢液；双侧腋窝淋巴结未触及肿

	大；双肺呼吸音清，心率齐，腹平软，无压痛。
辅助检查	1. 血常规：WBC： $12.5 \times 10^9/L$ ，N：82%，CRP：45mg/L（明显升高）；2. 乳腺超声：左侧乳房外上象限腺体回声不均，可见片状低回声区，无液性暗区（排除脓肿形成），血流信号丰富。
诊断	急性乳腺炎（哺乳期，左侧，未形成脓肿）
治疗方案	1. 哺乳指导：继续母乳喂养，按需哺乳，每次哺乳后用吸奶器排空剩余乳汁，避免乳汁淤积；哺乳时让婴儿含住整个乳头及大部分乳晕，避免乳头损伤；乳头清洁，每次哺乳前后用温水清洗。2. 药物治疗：头孢克洛胶囊，0.5g/次，3次/日，口服（饭后），抗感染，连服7天（服药期间可正常哺乳，对婴儿无影响）；布洛芬混悬液，10ml/次，必要时口服（体温 $\geq 38.5^{\circ}C$ 时），缓解发热、疼痛。3. 局部处理：冷敷（急性期48小时内），每日2次，每次15-20分钟，减轻红肿疼痛；48小时后改为热敷，促进局部血液循环，帮助炎症消退。
复诊提示	3天后复诊，评估症状缓解情况、体温变化；7天服药结束后复诊，复查血常规、乳腺超声；期间若出现红肿范围扩大、疼痛加重、局部出现波动感（提示脓肿形成），及时就医，需穿刺引流；若发热持续不退，及时调整抗生素；日常注意哺乳卫生，避免乳汁淤积，预防复发。

病例12： 腱鞘囊肿

项目	具体内容
就诊时间	2026-03-09 11:30
性别/年龄	女/32岁
主诉	右手腕背侧包块1个月，伴活动时轻微疼痛。
现病史	1个月前无明显诱因发现右手腕背侧出现一黄豆大小包块，质地较硬，表面光滑，无红肿、压痛，活动时包块可轻微移动，无明显疼痛；近1周因频繁用鼠标、键盘，活动时出现轻微疼痛，包块无明显增大，无麻木、无力，不影响日常生活。既往体健，无药物过敏史，无外伤史，长期从事办公室工作（频繁使用电脑）。
查体	

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）